

SINUSITIS MAKSILARIS



Sinusitis didefinisikan sebagai inflamasi mukosa sinus paranasal

Sinusitis pada beberapa sinus → multisinusitis

Sinusitis pada seluruh sinus → pansinusitis

Sinusitis berdasarkan waktu

- Sinusitis akut sering didiagnosis ketika terjadi 2-4 episode dalam 1 tahun dan jarak antara episode sinusitis tidak kurang dari 8 minggu.
- Sinusitis subakut terjadi selama 4-12 minggu
- Sinusitis kronis terjadi selama lebih dari 12 minggu

EPIDEMIOLOGI

- 12,6% dari populasi 29,3 juta orang dewasa di Amerika Serikat

Summary Health Statistic., 2009

- Wanita : Pria = 18 juta: 11,3 juta
- Rentan usia 45-64 tahun

Pleis et al., 2009

- Wanita > Pria
- Usia anak-anak <15 tahun
- Dewasa 25-64 tahun

Lemiengre et al., 2018



Sinusitis odontogenic maksilaris peningkatan.

Pada tahun 1970= 10-12%

Pada tahun 2020= 51,8%

Psillas et al., 2020

Infeksi akar gigi belakang
bagian atas yang berkaitan
sinus maksilaris

Tassoker., 2019



ETIOLOGI

Bakteri:

- *Streptococcus pneumonia*
- *Haemophilus influenza*
- *Moraxellacatarrhalis*

Virus

- *Rhinovirus*
- *Influenza virus*
- *Corona virus*

Psillas et al., 2020



FAKTOR RESIKO

1. Faktor usia

Terjadi penurunan system imunitas dan lebih rentan terhadap penyakit ISPA

2. Penyakit gigi

Infeksi pada gigi terutama gigi atas dapat meningkatkan resiko terjadinya sinusitis maksilaris

3. Perawatan di Rumah sakit

Pemasangan ventilator secara signifikan meningkatkan resiko sinusitis maksilaris

4. Perbedaan tekanan

Dapat meningkatkan resiko penyumbatan pada sinus



5. Perenang

Larutan klorin dalam air kolam renang mampu mengiritasi lapisan hidung

6. Alergi

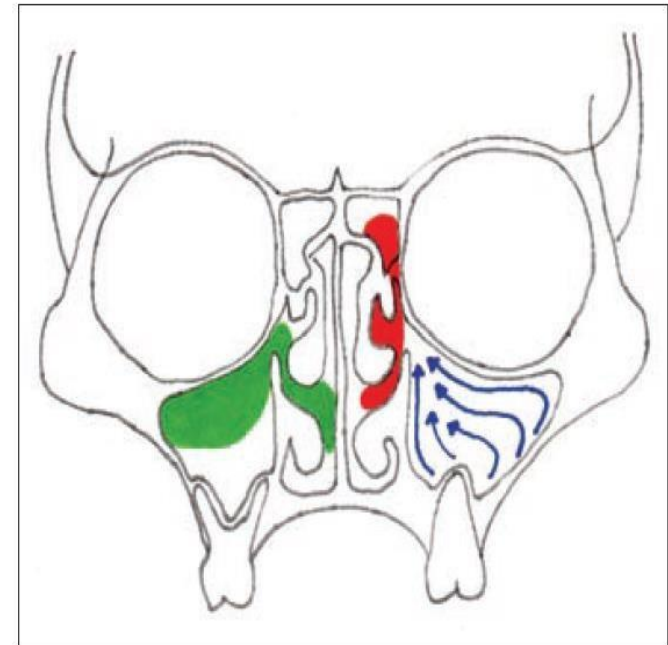
Rhinitis alergi mampu meningkatkan resiko sinusitis maksilaris sebanyak 30%

7. Rokok dan polusi udara

Menunda pembersihan mukosiliar



PATOGENESIS



ditegakkan jika memenuhi
 setidaknya 2 kriteria mayor, atau 1
 kriteria mayor ditambah ≥ 2 kriteria

Kriteria Mayor	Kriteria Minor
Discharge nasal anterior yang purulen	Sakit kepala
Discharge nasal posterior yang purulen atau berubah warna	Keluhan telinga berupa nyeri, rasa penuh, atau tertekan
Kongesti atau obstruksi nasal	Halitosis
Kongesti atau rasa penuh regio fasialis	Nyeri gigi
Hiposmia atau anosmia	Demam (untuk sinusitis subakut atau kronis)
Demam (untuk sinusitis kronis)	Fatigue

(Clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults, 2012)



Anamnesis

- hidung tersumbat
- produksi ingus purulen
- nyeri pada wajah
- gangguan mencium bau
- gejala sistemik atau gejala lain
- durasi gejala dialami
- Faktor risiko yang menimbulkan sinusitis

Pemeriksaan Fisik

- Inspeksi
- Pembengkakan di daerah pipi- kelopak mata bawah dengan perubahan warna kulit kemerahan
- Palpasi
- Nyeri tekan di daerah pipi

Pemeriksaan Penunjang

- Transiluminasi
- Endoskopi Nasal
- Rontgen
- Ultrasonografi



- **Terapi Simptomatis**

Terapi medikamentosa pada kasus sinusitis akut umumnya berupa pengobatan simptomatis seperti penggunaan dekongestan, kortikosteroid, dan analgesic (Brook and Bronze, 2018).

- **Dekongestan**

Dekongestan oral (pseudoefedrin atau fenilefrin) atau dekongestan topikal (pseudoefedrin HCl) yang diberikan selama 14 hari. Dekongestan topikal berupa oksimetazolin dapat diberikan dengan durasi tidak lebih dari 3 hari untuk mencegah kongesti *rebound* (Rosenfeld et al., 2015).

- **Kortikosteroid**

Kortikosteroid intranasal Regimen yang biasa digunakan adalah mometasone furoate 200/ 400/ 800 µg sebanyak 2 kali sehari selama 15 hari pemberian. Kortikosteroid oral jangka pendek misalnya metilprednisolon dengan dosis 3 x 8 mg selama 5 hari pemberian (Fokkens *et al.*, 2012).



▪ **Antihistamin**

Antihistamin tidak rutin diberikan. Antihistamin dapat bermanfaat pada sinusitis akut dengan gejala ringan (mengurangi keluhan bersin dan pengeluaran sekret hidung) atau yang diduga berhubungan dengan rhinitis alergi (Morcom *et al.*, 2016).

▪ **Analgetik**

Analgetik non-narkotik seperti paracetamol atau ibuprofen dapat digunakan pada pasien dengan sinusitis untuk meringankan keluhan demam dan nyeri (Wald *et al.*, 2013).



Terapi antibiotik pada kasus sinusitis bakterial akut dewasa adalah :

- **Amoxicillin** : 3 x 500 mg per oral atau amoksisilin klavulanat 3 x 625 mg per oral selama 10-14 hari pemberian
- **Klaritromicin** : 2 x 500 mg
- **Azythromycin** : 500 mg pada pemberian hari pertama, kemudian 1 x 250 mg selama 4 hari

Untuk sinusitis bakterial akut pada anak, pilihan antibiotik adalah :

- **Amoxicillin** : 45 mg/kgBB dibagi menjadi 2 dosis perhari
- **Ceftriaxone** : digunakan pada anak yang tidak mampu mentoleransi obat oral. Diberikan dengan dosis 50 mg/kg BB dosis tunggal secara intramuskular atau intravena



Terapi Lainnya

- Humidifikasi
- Cuci hidung
- Kompres hangat pada area hidung
- minum air putih

Terapi Pembedahan

FESS

Cadwell luc

Antrostomi inferior



Komplikasi pada daerah orbita	Komplikasi pada intrakranial	Komplikasi lain
edema palpebral	meningitis akut	osteomilitis
selulitis orbital	abses ektradural atau subdural	abses subpreiosteal
abses subperiostal	abses otak	
abses orbita		



- Sebagian besar kasus sinusitis bakterial akut tanpa komplikasi dapat ditangani sebagai pasien rawat jalan dengan prognosis yang baik.
- Pasien yang immunocompromised atau tampak toksik perlu rawat inap.
- Sinusitis jamur memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi

